

Expedientes de pacientes y usuarios · Escuela de Salud

Cómo leer esta propuesta

Documento para acordar los expedientes de pacientes y los registros de usuarios de la Escuela de Salud. Propone un bloque común y campos específicos por servicio. No certifica implementación ni sustituye la revisión clínica de cada disciplina.

Fisioterapia, Nutrición, Readaptación Deportiva y USC Casita aparecen en el directorio institucional incorporado al proyecto. Psicología es un área prevista cuyo servicio concreto debe confirmarse. USC Casita requiere precisar qué atenciones ofrece; no se le atribuyen especialidades por su nombre. La Unidad de Atención y Prevención de la Salud mantiene adscripción institucional por confirmar y no se asigna aquí automáticamente a Salud.

Cuando exista atención clínica individual, integrar la documentación clínica que corresponda. Para talleres, actividad deportiva o participación comunitaria no clínica, usar un registro de usuario y actividad, sin solicitar una historia clínica completa por defecto.

Separar módulos y permisos por servicio no implica crear historias desconectadas de una misma persona dentro del mismo establecimiento.

Base de revisión: la NOM-004 contempla identificación, historia, evolución, documentos aplicables, autoría y conservación. En Odontología, la NOM-013 desarrolla además la documentación propia del servicio. Las tablas son una propuesta de captura; no cada renglón constituye una obligación textual independiente.

Referencias consultadas

NOM-004-SSA3-2012, apartados 5, 6 y 10: referencia general sobre integración y documentos del expediente.
<https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5272787>

Directorio institucional de servicios; no define por sí mismo el contenido clínico ni la adscripción administrativa.
<https://www.unimodelo.edu.mx/servicios>

1. Campos comunes de atención clínica

El alcance de cada pregunta depende de la atención. En actividades no clínicas bastan identidad y contacto necesarios, actividad, consentimiento aplicable, asistencia, incidencias y responsable; no todos los antecedentes de esta tabla.

Campo	Qué significa / para qué sirve
Folio del expediente	Identificador estable para localizar a la persona sin confundirla con otra.
Establecimiento, escuela y servicio	Indica dónde se atiende y quién custodia el registro; incluir nombre, tipo y domicilio del establecimiento.
Nombre completo	Identifica al paciente o usuario; comprobar posibles duplicados antes de abrir otro expediente.
Fecha de nacimiento, edad y sexo	Datos de identificación y contexto de la valoración; mantener la edad vinculada a la fecha de atención.
Domicilio y contacto	Permiten localizar al paciente y acordar seguimiento; registrar teléfono y correo disponibles.
Representante y contacto de emergencia	Identifica quién representa al paciente cuando corresponda y a quién contactar; no son necesariamente la misma persona.
Necesidades de comunicación o apoyo	Idioma, accesibilidad y apoyos necesarios para comprender y participar en la atención.
Motivo de consulta	Lo que la persona solicita o le preocupa, preferentemente en sus propias palabras.
Antecedentes relevantes	Enfermedades, operaciones, hospitalizaciones y antecedentes familiares pertinentes al servicio.
Alergias y reacciones	Sustancia, reacción y fuente de información; distinguir desconocido de alergia negada.
Medicamentos y condiciones actuales	Tratamientos, suplementos y situaciones que puedan modificar la atención, cuando sean pertinentes.
Fecha, hora y profesional responsable	Relaciona cada atención con su autor, identificación profesional y firma aplicable.

2. Fisioterapia

Propuesta disciplinaria para validar con Fisioterapia; no es una lista de pruebas que deban aplicarse a todas las personas.

Campo	Qué significa / para qué sirve
Motivo y limitación funcional	Qué movimiento o actividad cotidiana resulta difícil y desde cuándo.
Antecedente de lesión o referencia	Origen del problema e indicaciones recibidas de otro profesional, si existen.
Dolor y síntomas	Ubicación, duración y medición con la escala elegida por el servicio.
Movilidad y fuerza	Resultados medidos, región evaluada y método utilizado.
Marcha, postura y equilibrio	Hallazgos pertinentes a la actividad y limitaciones observadas.
Pruebas funcionales	Instrumento o prueba aplicada, resultado y comparación en el tiempo.
Precauciones y señales de alerta	Situaciones identificadas que modifican la sesión o requieren otra valoración.
Valoración y objetivos	Problemas funcionales y metas acordadas, por ejemplo recuperar una actividad cotidiana.
Plan y dosificación	Técnicas o ejercicios, frecuencia y características definidas por el profesional.
Sesión y respuesta	Intervención realmente realizada, tolerancia, resultado e incidentes.
Programa domiciliario	Indicaciones explicadas y dificultades para seguirlas.
Reevaluación y alta	Cambio frente a la valoración inicial, metas logradas y continuidad.

3. Nutrición

Las medidas e indicadores se eligen según edad y contexto; el documento no prescribe dietas ni criterios diagnósticos.

Campo	Qué significa / para qué sirve
Motivo y objetivo personal	Qué desea mejorar la persona y qué espera de la consulta.
Historia alimentaria	Patrones de consumo, horarios y cambios relevantes, con el método de entrevista utilizado.
Alergias e intolerancias alimentarias	Qué alimento se relaciona con qué reacción; distinguir confirmación de sospecha.
Contexto y acceso a alimentos	Disponibilidad, preparación, preferencias y condiciones que afectan un plan realista.
Medidas corporales	Peso, talla y otras medidas pertinentes, con fecha, unidades y método.
Indicadores e interpretación	Resultado e interpretación profesional de los indicadores apropiados a la persona.
Información clínica y estudios	Antecedentes y resultados disponibles relevantes, sin solicitar estudios automáticamente.
Valoración nutricional	Problemas y necesidades identificadas por el profesional.
Plan acordado	Objetivos, pautas y adaptaciones al contexto de la persona.
Educación y materiales entregados	Temas explicados y recursos utilizados durante la consulta.
Seguimiento y dificultades	Cambios, tolerancia y barreras; no reducir el avance únicamente al peso.
Cierre o referencia	Resultados, continuidad y necesidad de atención por otro servicio.

4. Psicología — servicio por confirmar

Confirmar atención individual o grupal, edades, profesionales responsables y ruta de urgencias. Los relatos y resultados psicológicos requieren acceso especialmente delimitado; Dirección no necesita su contenido para contar prácticas.

Campo	Qué significa / para qué sirve
Motivo y expectativas	Razón de consulta y objetivos expresados por la persona.
Encuadre de atención	Modalidad, frecuencia, acuerdos de trabajo y límites de confidencialidad explicados.
Historia pertinente	Contexto personal, familiar y antecedentes relevantes, evitando detalles sin finalidad asistencial.
Funcionamiento actual	Cómo afecta la situación a la vida cotidiana y qué recursos de apoyo existen.
Valoración profesional	Hallazgos e interpretación dentro del alcance del servicio ofrecido.
Instrumentos utilizados	Nombre, versión, fecha e interpretación; no convertir una puntuación aislada en diagnóstico.
Riesgo y ruta de actuación	Valoración profesional pertinente y acciones ante una situación que requiera atención prioritaria.
Objetivos y plan	Metas y enfoque de intervención acordados.
Nota de sesión	Contenido clínico necesario, intervención, respuesta y próximos pasos; evitar transcripciones innecesarias.
Coordinación o referencia	Información mínima compartida con destinatario y motivo documentados.
Cierre y continuidad	Estado al concluir, acuerdos y seguimiento recomendado.

5. Ciencias del Deporte / Readaptación Deportiva

La práctica deportiva no clínica usa registro de usuario. Si hay rehabilitación clínica, se integra el módulo clínico correspondiente y se define el profesional responsable.

Campo	Qué significa / para qué sirve
Tipo de atención	Distingue actividad deportiva, evaluación, entrenamiento y readaptación de una lesión.
Actividad y objetivo	Disciplina, nivel de práctica y meta acordada con el usuario.
Antecedentes pertinentes	Lesiones, molestias y condiciones relevantes para la actividad propuesta.
Referencia o autorización profesional	Documento y restricciones cuando el caso requiere valoración por otro profesional.
Evaluación inicial	Pruebas pertinentes y resultados, con fecha y método.
Limitaciones y precauciones	Condiciones que obligan a adaptar, suspender o referir la actividad.
Plan de trabajo	Ejercicios, frecuencia, intensidad y progresión definidos por el responsable.
Carga realizada y asistencia	Qué actividad se completó realmente, tiempo y características de la sesión.
Respuesta y recuperación	Tolerancia, molestias e incidencias observadas o referidas.
Reevaluación y progresión	Criterios y resultados que sustentan ajustes; el software no autoriza por sí solo el retorno deportivo.
Cierre o continuidad	Metas logradas, pendientes y recomendaciones del responsable.

6. Atención Comunitaria / USC Casita

La oferta concreta de USC Casita debe confirmarse. Si durante una jornada se proporciona atención clínica individual, abrir o vincular el expediente clínico correspondiente y conservar separadas las estadísticas de participación.

Campo	Qué significa / para qué sirve
Programa y tipo de actividad	Identifica taller, orientación, visita, tamizaje o atención individual efectivamente ofrecida.
Fecha, sede y equipo responsable	Permite saber dónde ocurrió la actividad y quién la coordinó.
Participante o grupo destinatario	Usar identidad individual sólo cuando se necesita; para una actividad grupal puede bastar un conteo.
Necesidad u objetivo	Qué busca resolver la actividad y qué espera la persona o comunidad.
Autorizaciones pertinentes	Permisos de participación, representación e imágenes según el caso.
Actividad y asistencia	Qué se realizó, duración y participación real.
Mediciones o tamizajes	Instrumento y resultado cuando se apliquen; un tamizaje no equivale por sí solo a diagnóstico.
Hallazgos y orientación	Situaciones detectadas e información proporcionada dentro del alcance del servicio.
Referencia y seguimiento	A qué servicio se orientó, por qué y quién comprobará la continuidad.
Incidentes y respuesta	Hechos, medidas tomadas y responsable de atenderlos.
Resultado y cierre	Alcance conseguido, pendientes y valoración de la actividad.

7. Evolución, documentos y cierre

Aplicar este bloque a la atención clínica de cada disciplina. En el registro no clínico, adaptar seguimiento y autorizaciones a la actividad, sin simular diagnósticos ni notas clínicas.

Campo	Qué significa / para qué sirve
Situación desde la consulta anterior	Cambios, molestias, cumplimiento y dificultades expresadas por la persona.
Hallazgos de la sesión	Lo observado o medido y su interpretación; no marcar como normal algo no evaluado.
Intervención realizada	Qué se hizo realmente, en qué sitio y con qué características relevantes.
Respuesta e incidentes	Resultado inmediato, dificultades o eventos adversos y medidas tomadas.
Indicaciones y próximo seguimiento	Recomendaciones explicadas, responsable del seguimiento y fecha o criterio de revisión.
Referencia o interconsulta	Motivo, destinatario, resumen enviado y respuesta recibida; dar seguimiento al resultado.
Cierre del episodio	Motivo de alta o interrupción, resultados, pendientes e instrucciones de continuidad.
Documentos y estudios	Archivos identificados por fecha y autor, con interpretación profesional cuando corresponda.
Consentimiento informado	Intervención aceptada, explicación de alternativas y riesgos, fecha y firmas según el supuesto aplicable.
Privacidad y uso de imágenes	Registrar las autorizaciones correspondientes; enseñanza, difusión y atención no son la misma finalidad.
Aclaraciones posteriores	Correcciones identificadas con autor, fecha y motivo, preservando el registro original.

8. Prácticas de alumnos y acuerdos

Cada servicio define actividades acreditables, competencias y supervisores. Los informes de Dirección reúnen el avance de alumnos y ciclos, con datos mínimos de usuarios.

Acuerdos: confirmar servicios activos y responsables; distinguir actividades clínicas y no clínicas; aprobar campos por servicio; definir accesos, firmas y ruta de referencia. La IA puede apoyar organización y seguimiento administrativo, pero la valoración y validación clínica corresponden al profesional.

Campo	Qué significa / para qué sirve
Alumno y matrícula	Identifica al participante en la práctica; no sustituye al profesional responsable.
Programa, ciclo y asignatura	Ubica la actividad en el periodo académico y la formación correspondiente.
Supervisor y responsabilidad	Quién supervisa, revisa y valida; distinguir la firma del alumno de la del profesional.
Atención vinculada y actividad	Relaciona la práctica con una atención mediante un identificador interno, evitando copiar todo el expediente.
Participación del alumno	Distingue observación, asistencia y ejecución supervisada para no atribuir actividades que no realizó.
Fecha y tiempo acreditable	Registra participación real y tiempo validado, sin duplicar horas entre actividades.
Competencia y evaluación	Capacidad que se evalúa, criterio utilizado, resultado y observaciones del supervisor.
Estado de validación	Borrador, enviado, devuelto o validado; dejar evidencia de quién revisó y cuándo.
Evidencia académica	Referencia al trabajo realizado, con información mínima y desidentificada para informes docentes.
Informe individual y de ciclo	Resume actividades, horas, competencias, pendientes y validación; separar estos datos del detalle clínico.